# DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

## IDENTIFICACIÓN

**Paciente:** LAURA DANIELA GONZALEZ SANCHEZ **Identificación** CC 1234638392
**Edad:** 29 AÑOS **Empresa:** POLICIA NACIONAL URGENCIAS
**Sala:** QUIROFANO 3 **Fecha programación de cirugía:** 05/11/2026

**Sede de Atención:** SEDE PRINCIPAL

## CIRUGÍAS

| CANT | CÓDIGO | NOMBRE DE LA CIRUGÍA | Grupo Quirúrgico | UVR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **512104** | **COLECISTECTOMIA VIA LAPAROSCOPICA** | JHS | |

**Cirujano:** CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
**Vía:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **540015** | **DRENAJE DE COLECCION INTRAPERITONEAL VIA LAPAROSCOPICA** | FQV | |

**Cirujano:** CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
**Vía:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **540102** | **LIBERACION DE PLASTRON EN ABDOMEN VIA LAPAROSCOPICA** | GNW | |

**Cirujano:** CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
**Vía:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **541702** | **LAVADO PERITONEAL TERAPEUTICO VIA LAPAROSCOPICA** | GMW | |

**Cirujano:** CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
**Vía:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **545101** | **LISIS DE ADHERENCIAS PERITONEALES VIA LAPAROSCOPICA** | GPA | |

**Cirujano:** CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
**Vía:**

## DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

**CIRUJANO** ES183 CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ **Especialidad** CIRUGIA GENERAL

**512104** **COLECISTECTOMIA VIA LAPAROSCOPICA**
**540015** **DRENAJE DE COLECCION INTRAPERITONEAL VIA LAPAROSCOPICA**
**540102** **LIBERACION DE PLASTRON EN ABDOMEN VIA LAPAROSCOPICA**
**541702** **LAVADO PERITONEAL TERAPEUTICO VIA LAPAROSCOPICA**
**545101** **LISIS DE ADHERENCIAS PERITONEALES VIA LAPAROSCOPICA**

**Dx Preoperatorio:** K800 CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA

**Dx Postoperatorio:** K800 CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA

**Tipo de Herida:** LIMPIA CONTAMINADA **Tipo de Anestesia:** GENERAL **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
**Cantidad de Sangrado:** 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
**Clasificación de riesgo quirúrgico :** **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
**Realización Acto Quirúrgico:** **Fecha Inicio** 05/11/26 **Fecha Final** 05/11/26
**Hora Inicio** 08:00:00 **Hora Final** 09:00:00
**Tiempo de Perfusión:** 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

**Descripcion Quirúrgica:**

BAJO ANESTESIA GENERAL, PREVIA SEPSIA Y ANTISPESIA,
SE COLOCACN CAMPOS ESTERILES, SE REALIZA INCISION TRASNUMBILICAL BAJO TECNICA HASON SE PASA PRIMER PURETO DE 10 MM
SE PASA SEGUNDO PEURTO BAJO VISION DIRECTA FLANCO DERECHO DE 5 MM
SE PASA TERCER PUERTO BAJO VISION DIRECTA SUBXIFOIDEO DE 10 MM
SE EVIDENCIA:
PLASTRON VESIUCLAR VESIUCLAR MUY INFLAMADA, CON EPIPLON MAYOR, ESTOMAGO
ADHRENCIAS QUE RETRAEN EL HIGADO A LA PARED ABDOMINAL
VESICULA BILIARDE PAREDES MUY ENGROSADAS DE GRAN TAMAÑO CON MULTIPLES CALCULOS PEQUEÑOS EN SU INTERIOR.
LIQUIDO INFLAMATOIO PERIVESIUCALR Y QUE SE EXTOIENDE HASTA RECESO SUBDIAFRAGMATICO DERCHO 300 ML APROX
CISTICO CORTO Y ANCHO
VIA BIALIR PRINCIPAL NORMAL
ARTERIA CISTICA DE GRAN CALIBRE Y ANTERIOR
LECHO VESIUCLAR EDEMATIZADO Y CRUENTO

## DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

SE PROCEDE ACON DISECCION Y LEVANTAMEINTO DE ADHRENCIAS A HIGADO Y A ESTOMAGO
SE REALIZA DISECCION ROMA Y CON HIDRODISECCION DE PLASTRON VESIUCLAR
SE EVACUA LIQUIDO INFLAMATOIO EN RESESO SUBDIAFRAGMATICO Y SUBHEPATICO DE 300 ML
SE IDENTIFICACION LABORIOSA DE TRINGULO DE CALOT, SE TIENE VISION DE SEGURIDAD
SE REALIZA PINZAMEINTO CON CLIPS DE 400 SOBRE ARTERIA CISTICALA CUAL ESTA AUMENTADA DE TAMAÑO PROMEDIO SE CLIPA CON 2 CLIPS Y AL IGUAL A VASO POSTERIOR
SE REALIZA PÍNZAMEINTO CON CLIPS 400 SOBRE CONDUCTO CISTICO SE REALIZA CLIPADO CON 5 CLIPS MUYY CERCA A LA REAIZ DEL CISTICO CON EL CONDUCTO HEPATICO COMUN,
SE REALIZA COLECISTECTOMIA CISTOFUNDICA
LECHO VESIUCLAR CRUENTO Y DE SANGRADO FACIL
SE REALIZA HEMOSTASIA DE LECHO VESIUCALR
SE PROCEDE A LAVADO DE CAVIDAD ABDOMNINAL CON 1500 ML DE LIQUIDOS
Y SE EXTRAEN CUAGULOS
SE RETIRA VESIUCAL
SE TIENE CONTEO DE MATERIAL COMPLETO
SE RETIRAN PUERTOS Y NEUROMPERITONEO
SINTESIS D EPUERTOS CON VYCRIL 1
PIEL Y TCS CONPROLENE 3.0
FIN DE ACTO QUIURURGICO

**Complicaciones :** **SI** ☐ **NO** ☒

---

**Hallazgos :**

PLASTRON VESIUCLAR VESIUCLAR MUY INFLAMADA, CON EPIPLON MAYOR, ESTOMAGO
ADHRENCIAS QUE RETRAEN EL HIGADO A LA PARED ABDOMINAL
VESICULA BILIARDE PAREDES MUY ENGROSADAS DE GRAN TAMAÑO CON MULTIPLES CALCULOS PEQUEÑOS EN SU INTERIOR.
LIQUIDO INFLAMATOIO PERIVESIUCALR Y QUE SE EXTOIENDE HASTA RECESO SUBDIAFRAGMATICO DERCHO 300 ML APROX
CISTICO CORTO Y ANCHO
VIA BIALIR PRINCIPAL NORMAL
ARTERIA CISTICA DE GRAN CALIBRE Y ANTERIOR
LECHO VESIUCLAR EDEMATIZADO Y CRUENTO.

**Tejidos enviados a patología :** **SI** ☒ **NO** ☐

VESICUAL BILIAR

---

Carlos I Forero
CARLOS IVAN FORERO R. CIRUGÍA GENERAL R.M. 76-0629

CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ
Reg. 760629
CIRUGIA GENERAL

*** * * FIN DEL REPORTE * * ***